COLECTOMÍA IZQUIERDA, SIGMOIDECTOMÍA Y RESECCIÓN DE RECTO

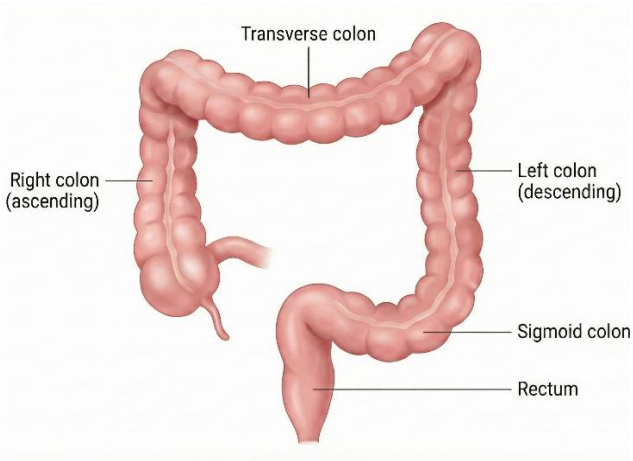
Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Mª Goretti González Mesa, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

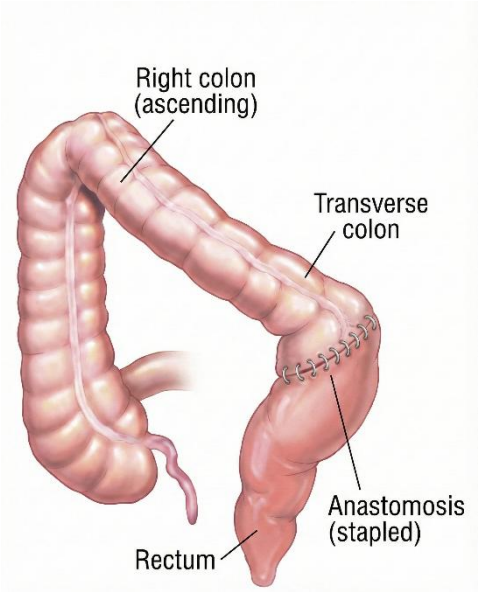
La colectomía es la extirpación quirúrgica total o parcial de una parte enferma del colon. Se denomina hemicolectomía cuando sólo se extirpa una mitad del colon, o intestino grueso. Puede ser hemicolectomía derecha, si se realiza exéresis de ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y parte del colon transverso (esta técnica se revisa en otro capítulo de este manual) o izquierda, cuando la exéresis es de la mitad izquierda del colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon descendente y del sigma. También se pueden realizar exéresis más reducidas como la sigmoidectomía. Si la resección implica el recto, según la altura de la resección, se puede abordar por vía exclusivamente abdominal en un procedimiento referido como resección anterior de recto.

Una de las principales indicaciones de estas técnicas es la exéresis de tumores propios del colon o con otro origen, y que infiltran el intestino grueso por vecindad como puede ser la vejiga o el útero. También se puede intervenir por patologías benignas como la enfermedad inflamatoria intestinal o la diverticulosis.

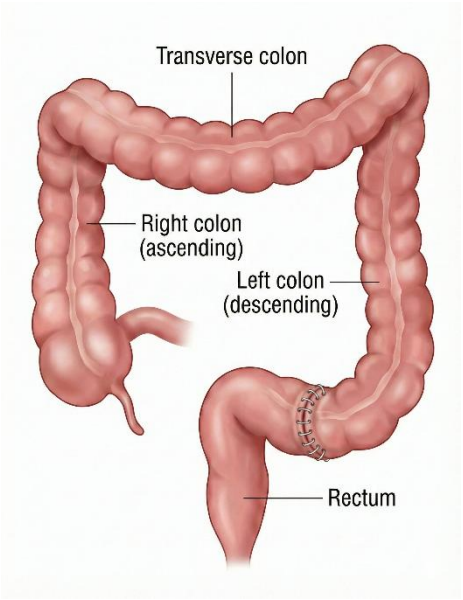
Anatomía normal



Hemicolectomía izquierda



Sigmoidectomía

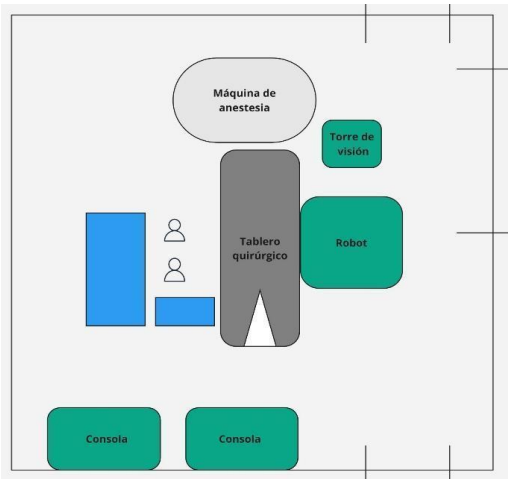


POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

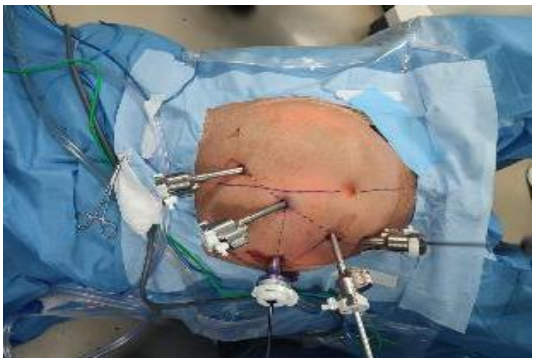
- Decúbito supino y brazos alineados al cuerpo.
- Perneras bajas.
  - Si el paciente es obeso y la sujeción de las perneras queda justa, se reforzará con venda crepé.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

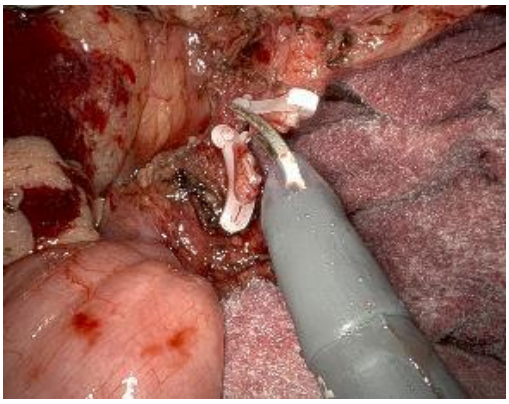
- Anatomía: abdominal inferior
- Lado: izquierdo
  - Brazo 1: Tip-up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Óptica de 30º
  - Brazo 4: Tijera / Vessel-sealer / Hem-o-lok
- Tablero quirúrgico:
  - Trendelemburg 25°
  - Side derecho 10-12°



TÉCNICA QUIRÚRGICA

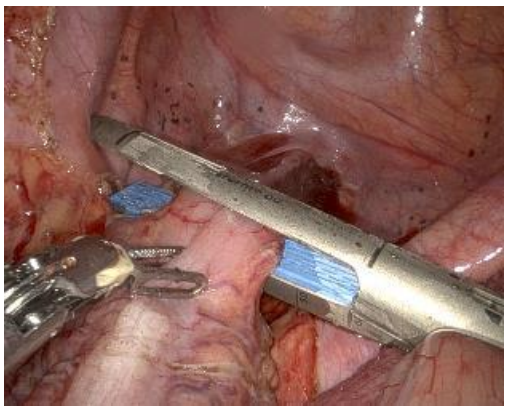


- Previa preparación del campo estéril, puede ser necesario hacer un lavado rectal, sobre todo cuando se trata de resecciones bajas. El lavado rectal se hace con solución iodada diluida en suero fisiológico.
- Colocación de campo y trócares.
- Revisión de la cavidad y resección de adherencias que puedan interferir con la visión o con la correcta disección de los elementos anatómicos necesarios para la cirugía. Esta revisión puede hacerse de forma laparoscópica, por lo que hay que tener dos grasper montados desde el inicio.
- Para una mejor separación de las estructuras y secado durante la cirugía, se usará un dispositivo QuirPad. Éste se prepara con dos gasas abiertas a lo largo y enrolladas, fijadas en cuatro puntos con seda.
- Movilización de las asas intestinales hacia lugar seguro donde no interfieran con la visión del campo quirúrgico, localización de la tumoración y comprobación de si existen signos de enfermedad extendida.
- Mediante tracción del colon hacia pared abdominal, se localizan los vasos mesentéricos inferiores, se procede a la apertura del peritoneo del pedículo y se disecan los vasos.
- Se localiza el uréter izquierdo para asegurar su integridad durante la cirugía.



- Se seccionan los vasos con hem-o-lok de DV.
- Se libera el parietocólico izquierdo hasta alcanzar el ángulo esplénico para conseguir la suficiente movilización del colon que permita hacer la anastomosis posterior y que ésta quede sin tensión.

- Distalmente, se diseca la unión recto-sigmoidea y se realiza la sección del mesorrecto con bipolar Maryland a la distancia del margen anal que se considere adecuado como límite de seguridad. Si la paciente es una mujer puede ser necesario elevar el útero y los anejos mediante un punto de fijación a la pared abdominal.
- Se corta el intestino distal con endograpadora de 60 azul, verde o negra, dependiendo del grosor y dureza del tejido.
- Se compruebe la vascularización de la zona donde quieren hacer la anastomosis con verde de indocianina y se marca la zona por donde terminar de resecar la pieza.



- Se realiza una incisión de asistencia, generalmente suprapúbica tipo Pfannestiel. Se protege la pared abdominal con un dispositivo tipo “Alexis” y un paño, evitando de esta forma la contaminación y posibles implantes tumorales al exteriorizar la pieza.
- Se realiza la resección de la pieza y se coloca el anvil de la autosutura circular dentro de la luz intestinal en el extremo proximal, cerrando la luz alrededor de su base con la enjaretadora.

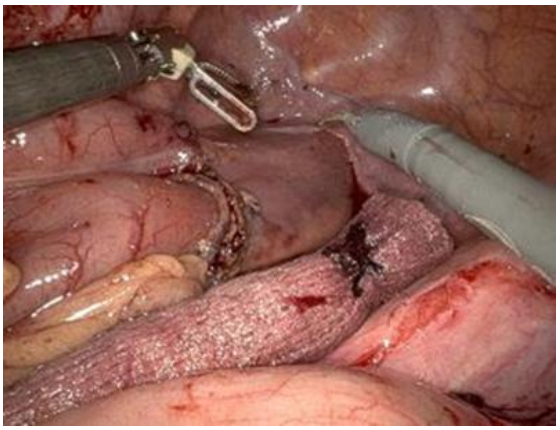
¡**IMPORTANTE**! El material utilizado en esta parte de la cirugía se considera sucio o contaminado, ya que entra en contacto con el contenido intestinal o está expuesto a él, por lo que debe desecharse o apartarse en cuanto se termine.

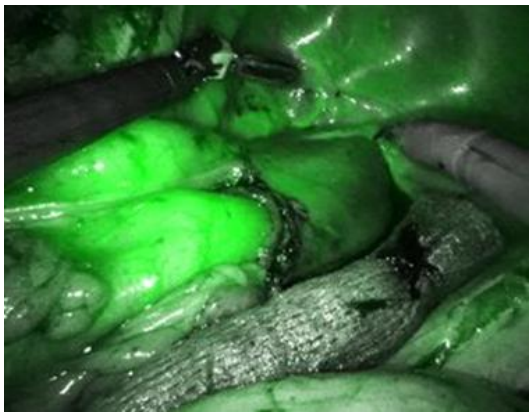
- Se cierra la herida de asistencia.

¡**IMPORTANTE**! El cierre de asistencia y el resto de la cirugía debe hacerse con material limpio que no haya estado en contacto ni expuesto al contenido intestinal.

- Se vuelve a tiempo laparoscópico para la anastomosis. Uno de los cirujanos comprueba la parte abdominal y el otro se sitúa entre las piernas para introducir la grapadora circular y comprobar la estanqueidad de la anastomosis.

- Se realiza la anastomosis intracavitaria.
- Se comprueba la buena vascularización de la anastomosis con verde de indocianina. Una posible aplicación sería: diluir 25 mg (un vial) en 10cc de agua bidestilada. Se suele inyectar la mitad de la dosis, es decir, 12.5 mg. Es conveniente arrastrar con un bolo de suero fisiológico la indocianina e inyectarle en una vía lo más proximal posible. Hay que tener cuidado con la dosificación máxima en pacientes especialmente susceptibles: mala función hepática, cardiópatas, etc. Respetando la recomendación de farmacia, no se deben administrar cantidades mayores a 0.3 mg/kg en pacientes cardiópatas y 0.5mg/kg en patologías hepáticas.





- Se retira el robot guardándolo estéril por si la anastomosis queda a tensión y hay que hay que ampliar la liberación del colon.
- En caso de que esté todo correcto se procede a la colocación de drenaje, revisión de hemostasia y cierre de heridas.

NOTAS

- Tener localizado un rectoscopio.
- En la mayoría de los casos es preciso lavar la ampolla rectal con suero y solución iodada antes de comenzar.
- En caso de que no haya verde de indocianina, comunicarlo a los cirujanos al inicio de la intervención.

BIBLIOGRAFÍA

1. Rouanet, P., Lehiany, M., Mourregot, A., Colombo, P.-E., & Taoum, C. (2023). Cirugía del cáncer de recto asistida por robot (X y Xi). *EMC - Técnicas Quirúrgicas - Aparato Digestivo*, *39*(4), 1–11. https://doi.org/10.1016/S1282-9129(23)48491-7